eonu 이어온유

환자 · 보호자 · 의료진 AI 소통 솔루션

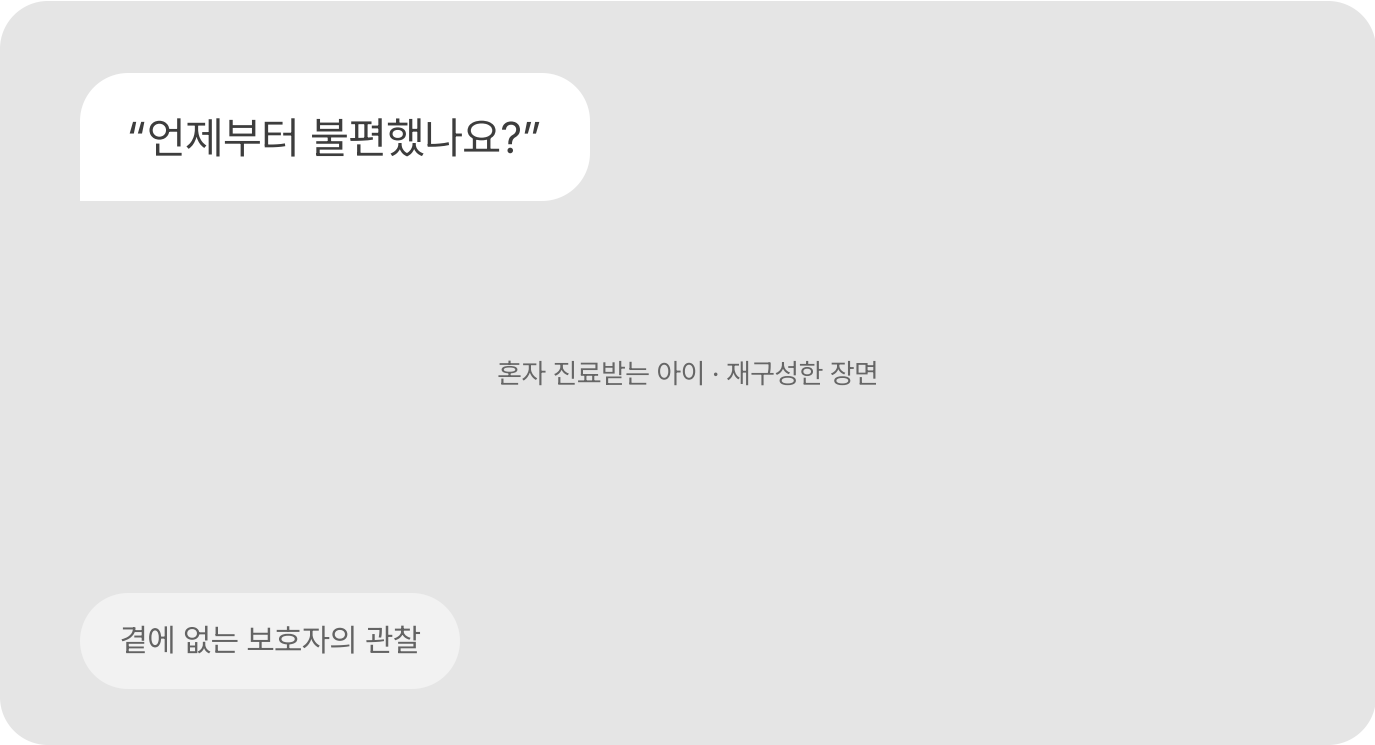
함께 오지 못해도,
이야기는 함께.



EONU IR · 2026.10.21

환자는 왔지만, 이야기는 오지 못했습니다.

혼자 진료받는 아이와, 곁에 있지 못한 보호자.



필요한 이야기도 함께 와야 합니다.

환자 경험을 설명하기 어렵고

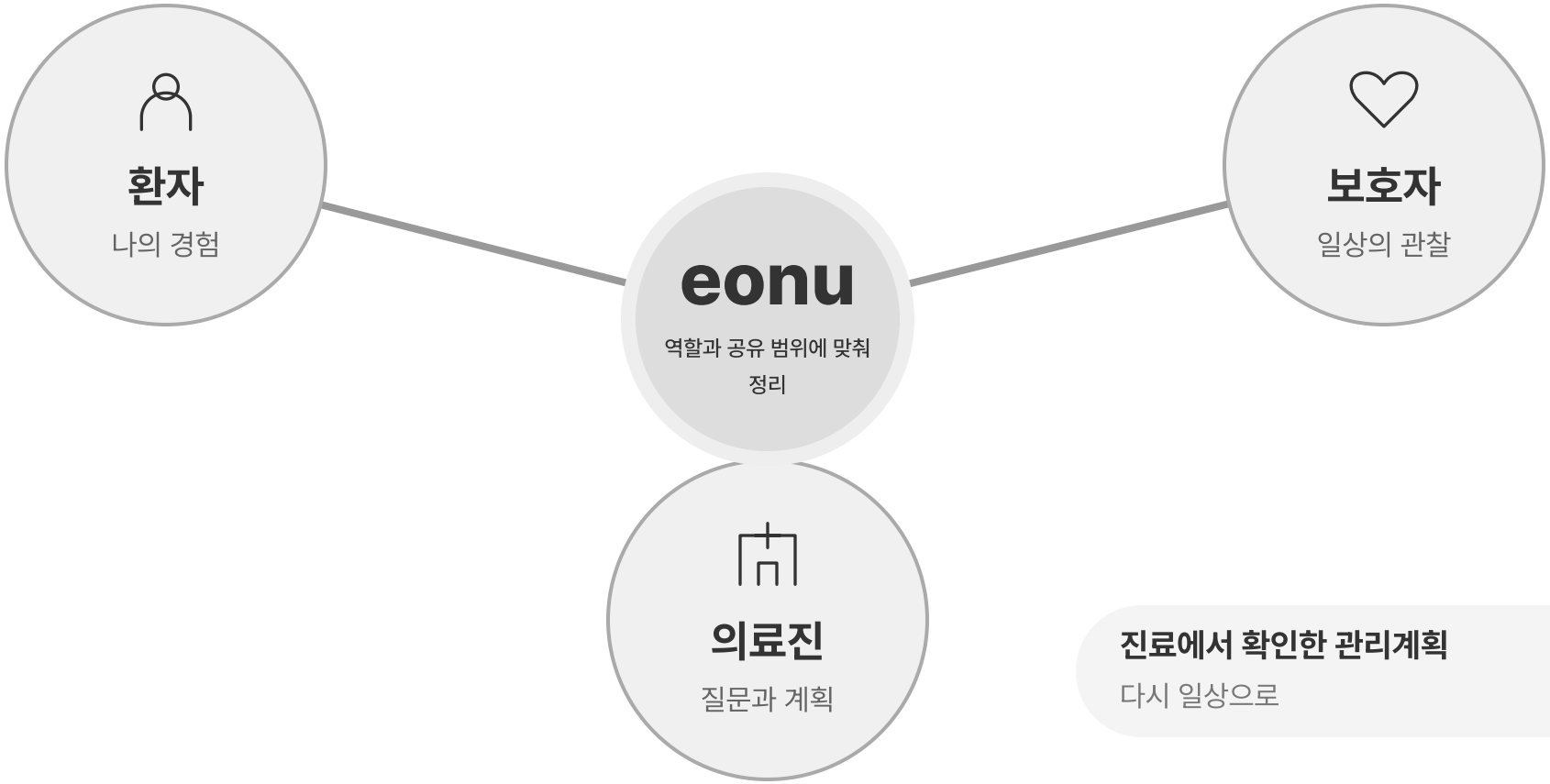
보호자 관찰을 전달하지 못하고

의료진 필요한 맥락을 확인해야 합니다

설명을 위해 재구성한 사례

세 사람의 이야기, 하나의 흐름으로.

환자의 경험 · 보호자의 관찰 · 의료진의 질문과 계획



환자의 걱정이, 병원의 상담 기회로.

의료진이 계속 참여할 세 가지 이유. 먼저 수익 기여 가능성을 검증합니다.

01

진료 효율

전체 업무 부담 확인

02

임상적 유용성

진료에 쓰이는 정보 확인

먼저 검증할 가설

수익 기여

자발적인 상담 요청과
병원의 지불 의사

환자의 일상

미해결 걱정

→

병원이 제공한 정보

관련 서비스 탐색

→

환자의 선택

자발적인 상담

AI가 개별 치료의 필요성을 판단하지 않습니다.

병원이 묻고, 일상에서 답합니다.

질문·서비스 정보·관리 안내를 먼저 설정합니다.

병원 설정

설명용 제품 UI

다음 진료에 필요한 질문부터.

01	**확인할 질문**	최근 수면은 어땠나요?
02	**서비스 정보**	병원이 제공한 안내
03	**진료 후 관리**	일상에서 확인할 계획

의료진의 기준으로 설정

→

병원 안내 QR

환자 · 보호자 사용 시작 이미지

병원과 연결된 화면으로 입장

설명용 제품 구조 · QR은 사용 시작 경로

기록은 편하게. 전달은 확인하고.

병원 설정 → 일상 기록 → 공유 전 확인 → 의료진 확인

01 기록

오늘의 기록 환자 · 보호자

월 화 수 목 금

✓ 수면 상태 확인

일기 · 음성 · 체크

편한 방식으로 남깁니다

AI가 요약 초안 정리 →

02 공유 전 확인

전달할 내용을 확인해요 직접 확인

원문

어제는 잠들기까지
오래 걸렸어요.

AI 요약 초안

잠들기 어려움
기록됨

✓ 원문과 요약 확인

✓ 공유할 항목 · 범위 조정

선택한 내용만 전달 →

03 의료진 확인

진료 전 확인 의료진

수면 기록

환자 작성 · 본인 확인

일상 관찰

보호자 작성 · 확인 상태 표시

진료 후

관리계획 안내

다시 일상에서 확인

병원 설정 → 기록 → AI 초안 → 당사자 확인 → 의료진 확인 → 관리계획

첫 매출의 출발점은 병원 라이선스.

일차의료기관에서 유료 도입을 검증하고, 다음 고객으로 넓힙니다.

첫 매출 가설

B2B

일차의료기관
소프트웨어 라이선스

첫 병원군 · 가격 선정 및 검증 중

01 **가상 사례 검토**

02 **범위가 정해진 제한 실증**

03 **유료 제안 → 계약**

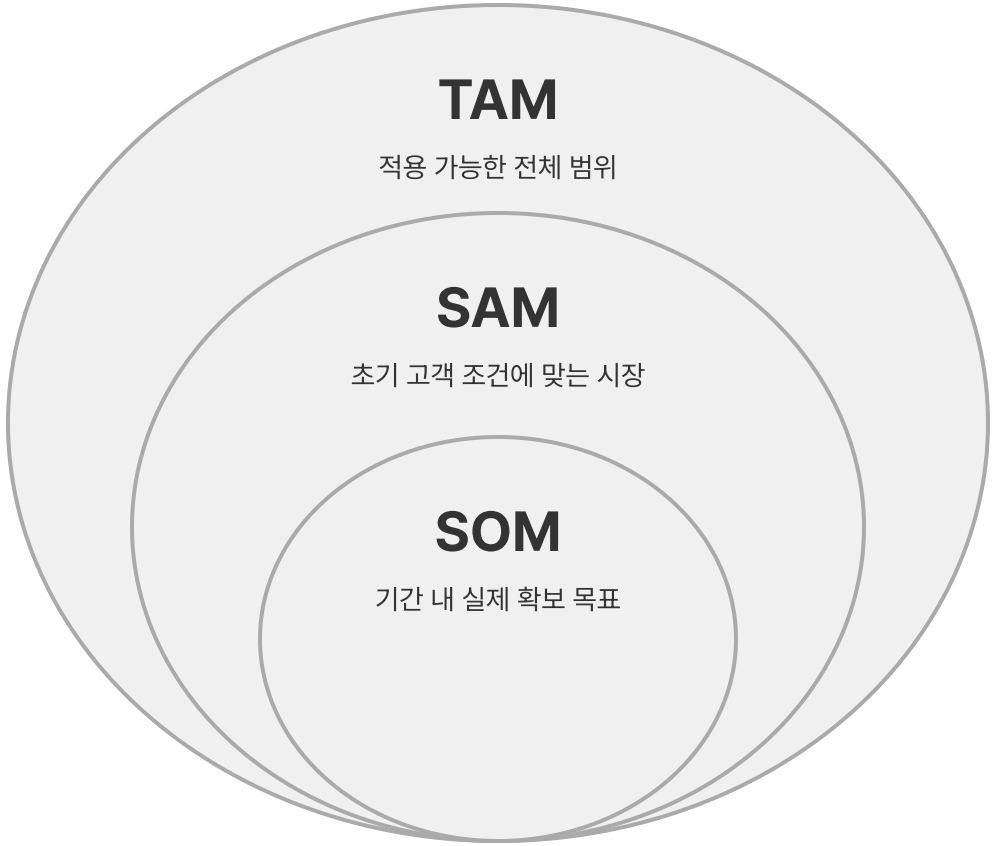
B2B2C 추가 유료 가치 확인 후 확장

B2G 실제 구매기관 · 예산 · 계약을 확인하는 별도 경로

연구지원금 · 민간 봉사활동과 구분

큰 시장에서, 먼저 살 고객을 좁힙니다.

현재 판매할 소프트웨어를 기준으로 TAM · SAM · SOM을 구분합니다.



현재 판매할 소프트웨어 기준

B2B	기관 수 × 연간 가격
B2B2C	연결 이용자 × 유료 전환율 × 연간 이용액
B2G	구매사업 수 × 계약 단가

입력값은 산정 전 · 동일 계약 중복 제외
미래 하드웨어 · 연구지원금 제외

범위와 산식 개념도 · 면적은 금액에 비례하지 않으며 시장 수치·가격은 산정 전

일상 기록에서, 연결된 건강 정보로.

병원 도입 검증 이후, 정보의 임상적 유용성과 입력 부담을 확인합니다.



일상 기록 · 건강 정보 연결 이미지

병원 도입 검증 이후

ADHD · 노년층은
후속 확장 · 연구 방향

현장 피드백을, 첫 도입으로.

질문과 템플릿, 제품에 반영할 운영 경험을 모으고 있습니다.

현재 확인된 접점

- **정신과 전문의 피드백**
  지속적 피드백 기재
- **의료혁신 연구기관 접점**
  협의 범위 확인 필요
- **청년 우울증 봉사 프로젝트**
  참여 확정 기재

공식 제휴 · 실증 · 유료 계약 실적과 구분합니다.

다음에 증명할 것

접점을,
도입의 근거로.

의료진의 실제 활용

전체 업무 부담

반복 사용 · 구매 의사

질문 · 템플릿 · 운영 경험 축적

1억 원, 첫 유료 모델을 향한 실행 자금.

의료·AI 이해를 바탕으로 직접 기획하고, 개발하고, 수정합니다.



기획 → 개발 → 수정

의료 · AI 이해를 바탕으로 직접 실행

사용계획 총액

1억 원

제품	보안	실증	고객 확보	운영

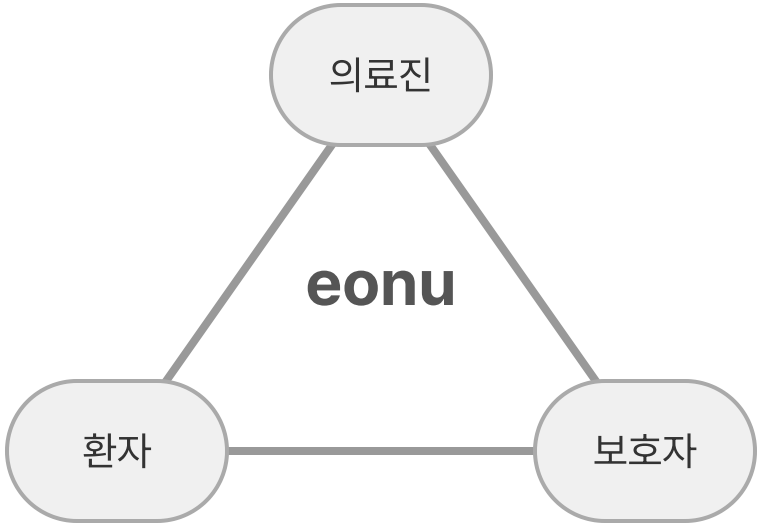
첫 유료 모델 검증

소개 · 직접 접촉 → 방문 데모 → 파일럿

세부 배분 · 기간 · 실증 및 유료 고객 목표 · CAC 확정 전

eonu 이어온유

환자에게 필요한 연결.
병원도 계속 쓸 이유.



세 사람의 안심을 잇는 서비스 이미지

이어지는 진료, 세 사람의 안심

EONU 이어온유

함께 오지 못해도,
이야기는 함께.

환자 · 보호자 · 의료진을 잇는
AI 소통 솔루션

IR 기획 개선본 · 2026.10.21



환자 · 보호자 · 의료진의 일상 장면

사람의 안심을 만드는

어지는 진료, 이어온유.

환자는 왔지만, 이야기는 오지 못했습니다.

혼자 진료받는 아이와, 곁에 있지 못한 보호자.

재구성한 사례



혼자 진료받는 아이 · 재구성한 설명용 장면

환자 **"언제부터였는지…
잘 모르겠어요."**

보호자 **관찰을 알고 있지만,
지금 곁에 없습니다.**

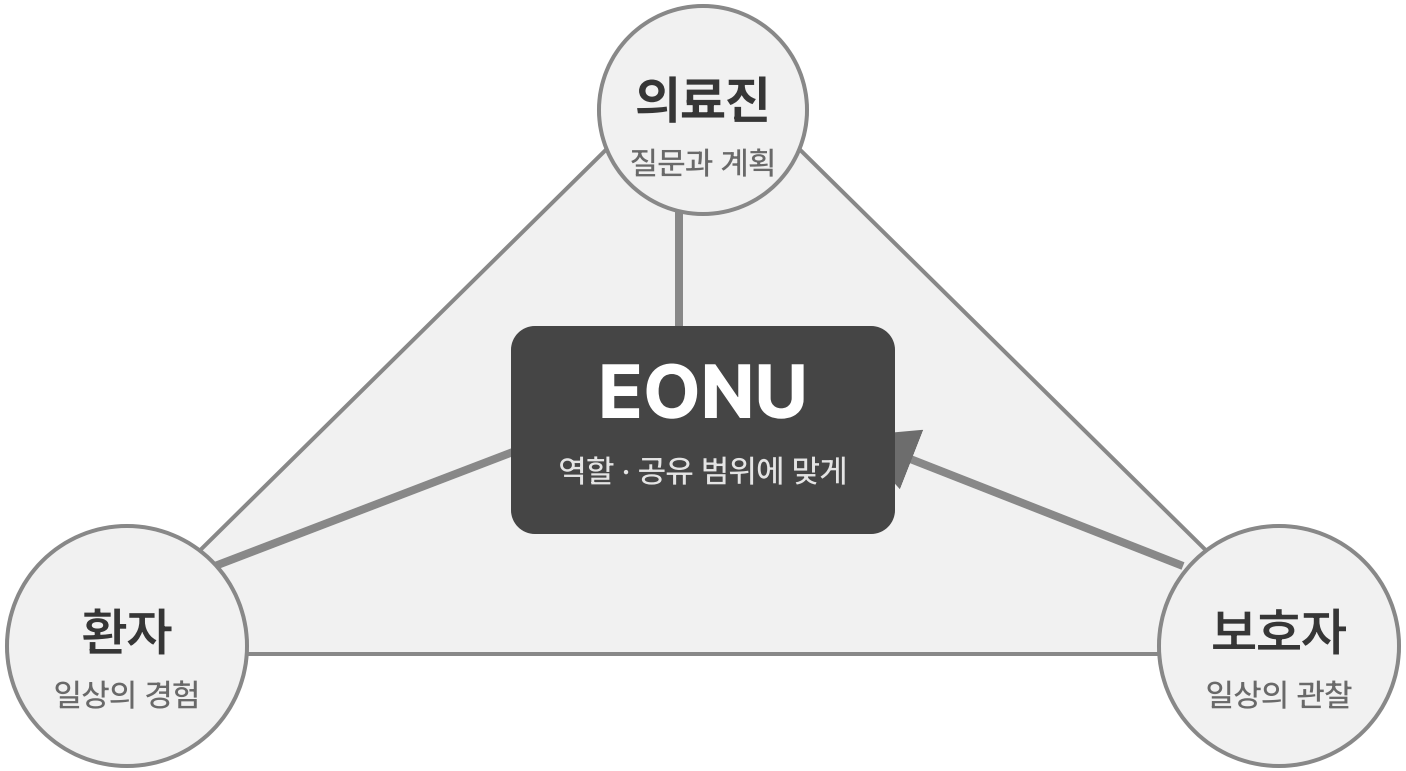
의료진 **필요한 정보를
짧은 시간 안에.**

동행의 부재가 만드는 **정보 전달의 공백.**

설명을 위해 재구성한 사례

세 사람의 이야기, 하나의 흐름으로.

환자의 경험 · 보호자의 관찰 · 의료진의 질문과 계획



진료에서 확인한

관리 계획

↓

다시, 일상으로

다음 진료까지
이어지는 소통

경험과 관찰을 병원의 질문에 맞춰 정리하고, 확인한 계획을 되돌려 줍니다.

환자의 걱정이, 병원의 상담 기회로.

의료진이 계속 참여할 세 가지 이유. 먼저 수익 기여 가능성을 검증합니다.

01
진료 효율

02
임상적 유용성

03
수익 기여

먼저 검증할 가설 · 자발적인 상담으로 이어질까?

01
미해결 걱정
일상의 걱정을 구체화

→

02
병원 정보
관련 서비스의 정보 탐색

→

03
자발적 상담
환자가 선택한 상담 요청

검증: 상담 요청 · 지불 의사 · 전체 업무 부담

AI가 개별 치료나 비급여의 필요성을 판단하지 않습니다.

사업 가설 · 비급여 필요성과 상담 전환 성과는 검증 전

병원이 묻고, 일상에서 답합니다.

질문·서비스 정보·관리 안내를 먼저 설정합니다.

출발점은 의료진의 참여

병원 설정과 안내를 사용하는 장면

의료진 → EONU → 환자 · 보호자

질문	다음 진료 전 확인할 항목
정보	병원의 서비스 정보
관리	진료 후 안내와 관리 계획

병원 안내 QR → 병원과 연결된 화면에서 시작

05. 데모 흐름

기록은 편하게. 전달은 확인하고.

병원 설정 → 일상 기록 → 공유 전 확인 → 의료진 확인

01 병원 설정 → **02 일상 기록** → **03 공유 전 확인** → **04 의료진 확인**







의료진의 관리 계획 ← 작성자와 확인 상태 구분 ← 공유할 내용 확인

가상 데이터 · 설명용 UI 도식 · 실제 서비스 캡처 및 EMR 연동 아님
설명용 데모 · 실제 서비스 화면 및 EMR 연동 아님

이어지는 진료 · 세 사람의 안심

첫 매출의 출발점은 병원 라이선스.

일차의료기관에서 유료 도입을 검증하고, 다음 고객으로 넓힙니다.

INITIAL BUSINESS

B2B

일차의료기관
소프트웨어 라이선스

유료 도입 검증 → **B2B2C**

환자 · 보호자의 추가 유료 가치, 후속 검토

1 **가상 사례**
검토

2 **제한 실증**
범위 · 기간 · 동의

3 **유료 제안**
가치 · 지불 의사

4 **계약**
구분 관리

별도 경로 · B2G 실제 공공 구매기관과 예산을 기준으로 검증

사업 모델 가설 · 첫 병원군과 가격은 선정·검증 중

이어지는 진료·세 사람의 안심

큰 시장에서, 먼저 살 고객을 좁힙니다.

현재 판매할 소프트웨어를 기준으로 TAM · SAM · SOM을 구분합니다.



B2B

기관 수 × 연간 가격

B2B2C

연결 이용자 × 유료 전환율 × 연간 이용액

B2G

구매사업 수 × 계약 단가

입력값·가격 산정 전 / 미래 하드웨어·연구지원금·동일 계약 중복 제외

범위와 산식 개념도 · 면적은 금액에 비례하지 않으며 시장 수치·가격은 산정 전

이어지는 진료 · 세 사람의 안심

08. 확장

일상 기록에서, 연결된 건강 정보로.

병원 도입 검증 이후, 정보의 임상적 유용성과 입력 부담을 확인합니다.

환자 중심

입력 부담 · 반복 사용



환자와 가족의 일상 기록 장면

일상 기록

EONU

임상적 유용성 확인

병원 시스템 · EMR

권한과 연동 비용 확인

외부 건강 앱

환자 · 가족의 정보 연결 검토

기기 · 디지털 바이오마커

ADHD · 노년층 대상 후속 연구

병원 도입 검증 이후의 확장 방향 · 연동 및 임상 검증 완료를 뜻하지 않습니다.

확장 방향 · EMR·외부 앱·기기 연동 및 바이오마커는 후속 검토·연구

이어지는 진료 · 세 사람의 안심

현장 피드백을, 첫 도입으로.

질문과 템플릿, 제품에 반영할 운영 경험을 모으고 있습니다.

현재 자료에서 확인되는 접점

피드백	**정신과 전문의의 지속적인 의견 수렴**
기관 접점	**디지털의료 연구기관과의 접점**
참여 확정	**청년 우울증 관련 봉사 프로젝트**

NEXT VALIDATION

다음에는, 실제로 쓰이고 지불할 가치까지.

활용	의료진의 실제 사용
부담	전체 업무 부담
지속	반복 사용과 구매 의사

MVP 범위 · 협력 상태는 증빙으로 확정 / 공식 제휴·실증·유료 계약과 구분

현재 접점 · 공식 제휴·실증·유료 계약 실적과 구분

1억 원, 첫 유료 모델을 향한 실행 자금.

의료·AI 이해를 바탕으로 직접 기획하고, 개발하고, 수정합니다.

직접 기획 · 개발하는 창업자

기획 → 개발 → 수정

의료 · AI 이해를 바탕으로
직접 만드는 실행력

사용계획 총액 · 세부 배분·기간·목표는 확정 전

1억 원 계획된 사용 총액

제품	구현과 반복 개선	**보안**	개인정보 · 보안 체계
실증	현장 운영과 확인	**고객**	소개 · 접촉 · 방문 데모
운영	첫 유료 모델의 기반	**협력**	임상 · 보안 · 실증

첫 유료 모델 검증 배분 · 기간 · 기관 수 · CAC는 확정 전

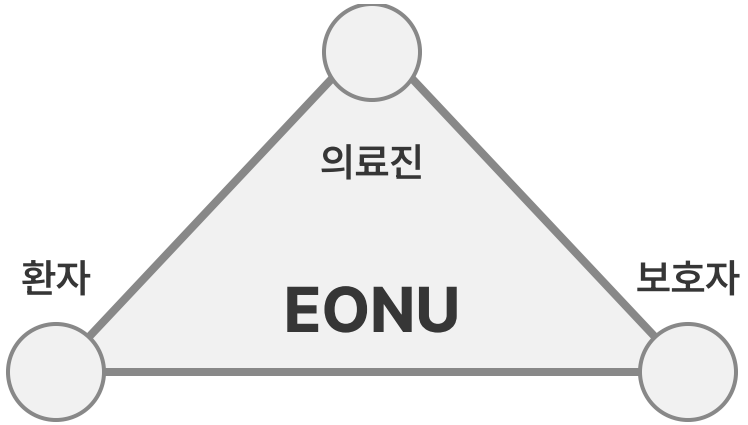
EONU 이어온유

환자에게 필요한 연결.
병원도 계속 쓸 이유.

실제로 쓰이고, 지불할 가치가 있는지.
첫 병원군과 함께 검증하겠습니다.

이어지는 진료, 세 사람의 안심.

환자 · 보호자 · 의료진이 이어지는 장면



EONU / 이어온유

함께 오지 못해도,
이야기는 함께.

환자 · 보호자 · 의료진을 잇는
AI 소통 솔루션

IR PROPOSAL / 2026.10



세 사람의 일상과 진료 장면

일상의 이야기가
다음 진료로 이어지도록.

01

환자는 왔지만,
이야기는 오지 못했습니다.



혼자 진료받는 아이 · 재구성 장면

동행의 부재 → 정보의 공백

“언제부터 달라졌나요?”

아이의 경험은 설명이 어렵고
보호자의 관찰은 현장에 없습니다.
의료진은 필요한 정보를 찾아야 합니다.

설명을 위해 재구성한 사례

설명을 위해 재구성한 사례

02

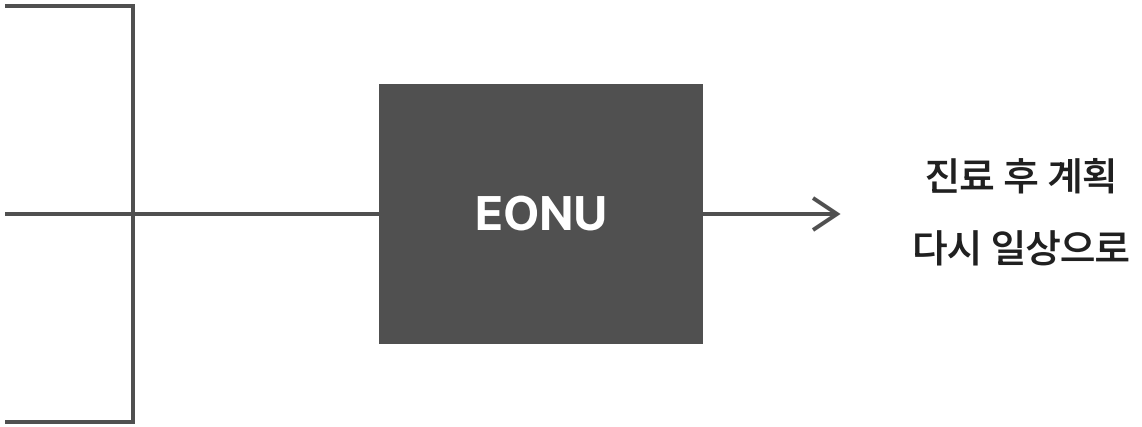
세 사람의 이야기, 하나의 흐름으로.

각자의 필요

환자 내 상황을 이해받고 싶습니다

보호자 관찰을 전달하고 도울 일을 알고 싶습니다

의료진 질문에 맞는 정보를 확인하고 싶습니다



경험 + 관찰 + 질문을 하나의 흐름으로

서비스가 지향하는 연결 구조

03

환자의 걱정이,
병원의 상담 기회로.

병원이 참여할 이유

01 **진료 효율**

전체 업무 부담 확인

02 **임상적 유용성**

실제 진료 활용 확인

03 **수익 기여**

초기 검증에 집중할 가설

걱정에서 자발적인 상담까지

미해결 건강 걱정

관련 병원 정보

환자가 선택하는 상담 요청 →

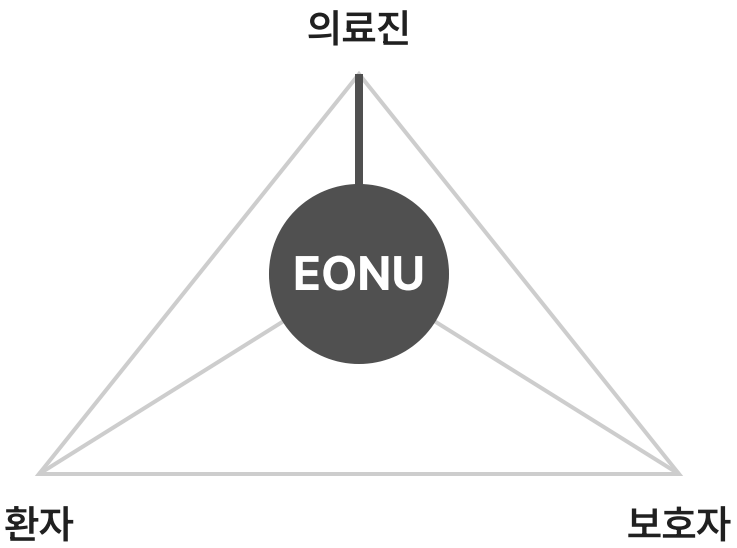
AI는 개별 치료·비급여의
필요성을 판단하지 않습니다.

사업 가설 · 비급여 필요성과 상담 전환 성과는 검증 전

04

병원이 묻고,
일상에서 답합니다.

01 / 의료진 설정에서 시작



질문 · 서비스 정보 · 관리 안내

병원 안내 QR · 시작 화면 이미지

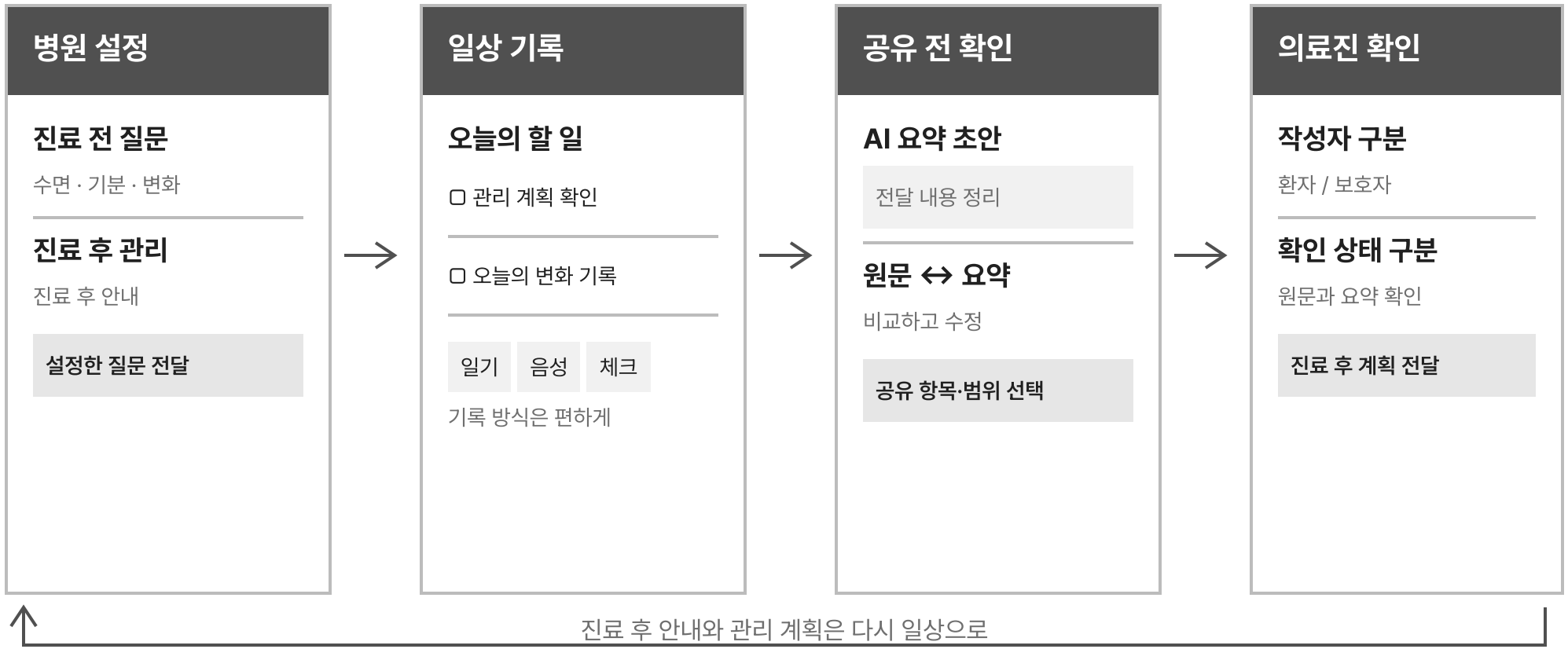
병원 설정 → 환자·보호자 진입

QR은 사용 시작 경로입니다.

설명용 제품 구조 · QR은 사용 시작 경로

05

기록은 편하게.
전달은 확인하고.



설명용 데모 · 실제 서비스 화면 및 EMR 연동 아님

06

첫 매출의 출발점은 병원 라이선스.

FIRST CUSTOMER

B2B

일차의료기관 라이선스

유료 도입 가치 검증

NEXT VALUE

B2B2C

환자·보호자 추가 가치

유료 가치 후속 검토

SEPARATE ROUTE

B2G

공공 구매기관

구매 예산·계약 검증

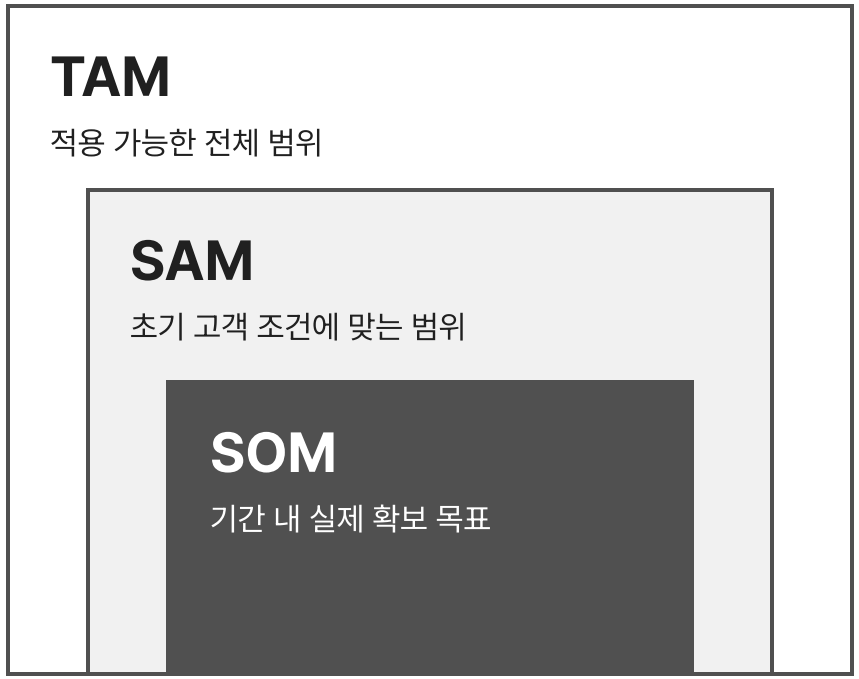
계약과 실증을 구분합니다

가상 사례 검토 → 제한 실증 → 유료 제안 → 계약

사업 모델 가설 · 첫 병원군과 가격은 선정·검증 중

07

큰 시장에서,
먼저 살 고객을 좁힙니다.



범위와 산식 개념도 · 면적은 금액에 비례하지 않으며 시장 수치·가격은 산정 전

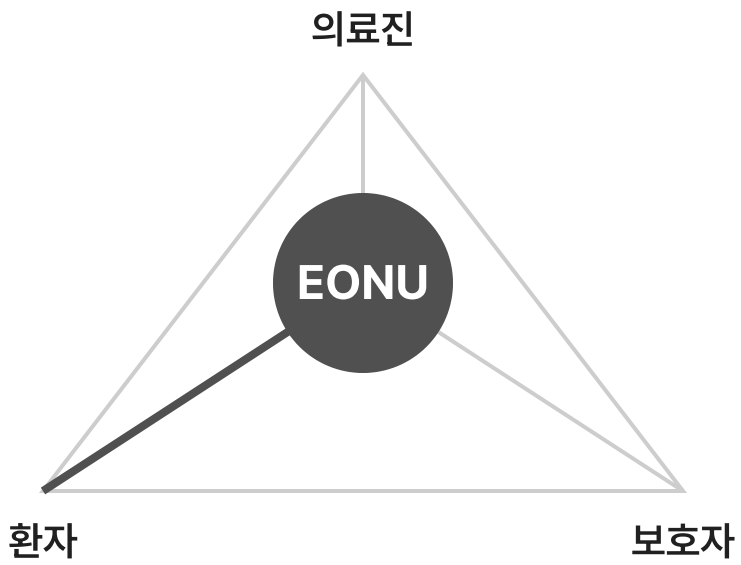
구매 단위별 산식

B2B	기관 수 × 연간 가격
B2B2C	연결 이용자 × 유료 전환율 × 연간 이용액
B2G	구매사업 수 × 계약 단가

시장 수치·가격 산정 전
하드웨어 · 연구지원금 · 중복 계약 제외

08

일상 기록에서,
연결된 건강 정보로.



02 / 환자 정보의 임상적 유용성
입력 부담과 반복 사용도 함께 확인

EMR · 병원 시스템
권한과 연동 비용 검토

환자·가족의 외부 건강 앱
정보 연결 가능성과 입력 부담 검토

기기 · 디지털 바이오마커
ADHD · 노년층 대상 추가 연구 과제

확장 방향 · EMR·외부 앱·기기 연동 및 바이오마커는 후속 검토·연구

09

현장 피드백을, 첫 도입으로.

현재 자료에 기재된 접점

정신과 전문의

지속적인 피드백

디지털의료혁신연구소

기관 접점 · 협의 범위 확인

청년 우울증 봉사 프로젝트

참여 확정 기재

자문·접점·봉사 참여는 공식 제휴·실증·유료 계약 실적과 구분합니다.

다음 검증과 축적 자산

확인할 것

실제 활용 · 전체 업무 부담
반복 사용 · 구매 의사

쌓을 것

질문 · 템플릿
운영 경험

현재 접점 · 공식 제휴·실증·유료 계약 실적과 구분

10

1억 원, 첫 유료 모델을 향한 실행 자금.



직접 기획하고
개발하고 수정합니다.

사용계획 총액 · 세부 배분·기간·목표는 확정 전

의료와 AI 이해를 실행으로

제품 → 보안 → 실증
→ 고객 확보 → 운영

임상 확인 · 개인정보·보안 · 실증 운영에
필요한 협력을 연결합니다.

1억 원

사용계획 총액

세부 배분 · 기간 · 목표 확정 전

소개 · 직접 접촉 → 방문 데모 · 파일럿 → 첫 유료 모델 검증

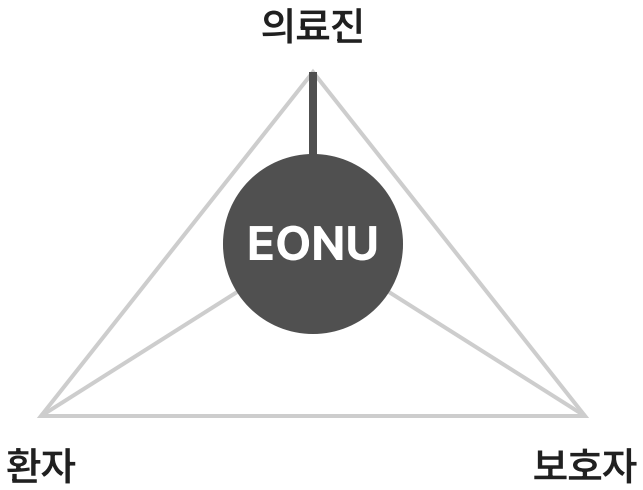
EONU / 이어온유

환자에게
필요한 연결.

병원도
계속 쓸 이유.

첫 병원군과 함께, 실제로 쓰이고 지불할 가치를 검증합니다.

함께 이어지는 일상 이미지

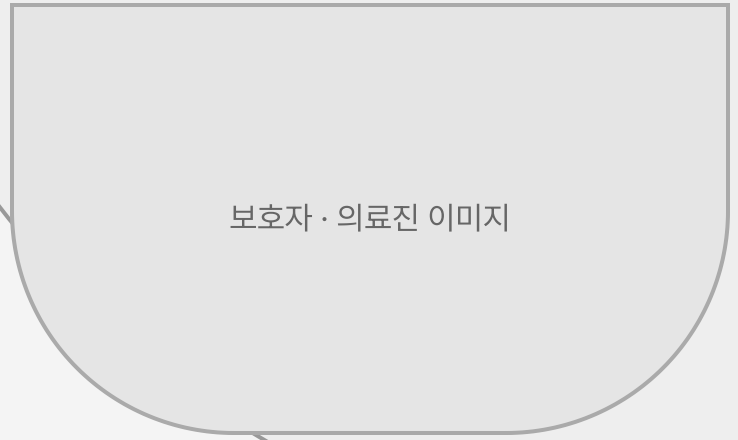


EONU

함께 오지 못해도,
이야기는 함께.

환자 · 보호자 · 의료진의
AI 소통을 잇는 이어온유



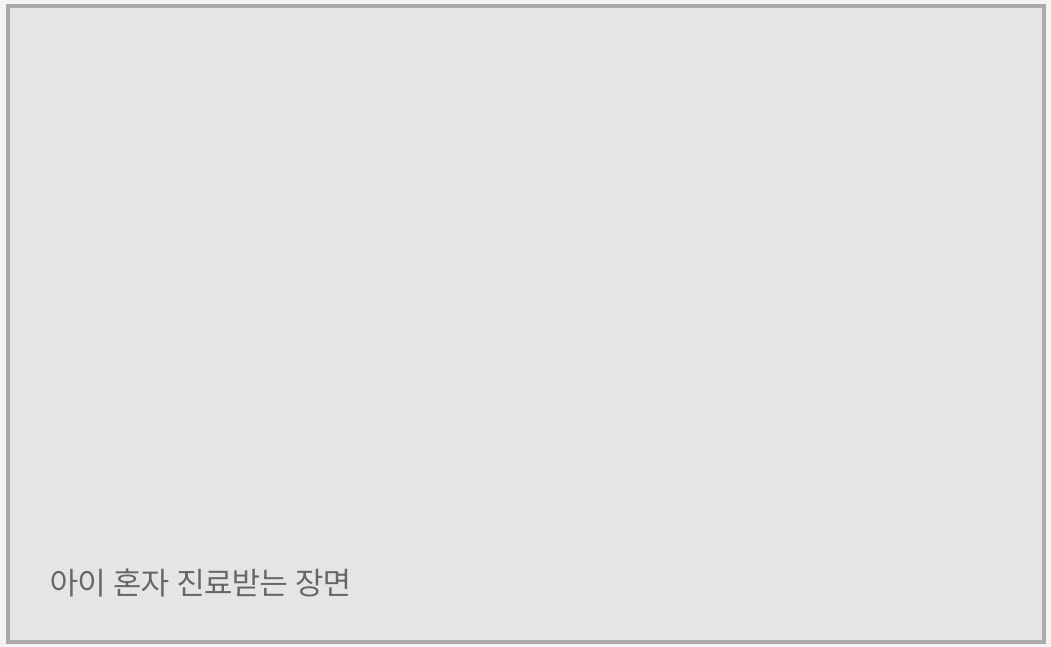


EONU IR / 2026.10.21

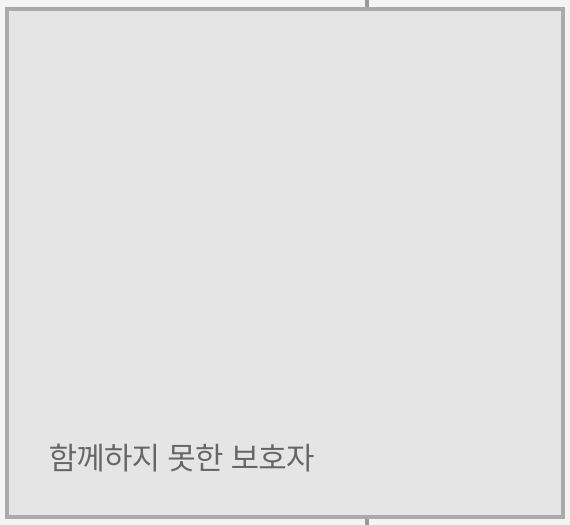
01. 문제

환자는 왔지만,
이야기는 오지 못했습니다.

혼자 진료받는 아이와, 곁에 있지 못한 보호자.



아이 혼자 진료받는 장면



함께하지 못한 보호자



정보를 확인하는 의료진

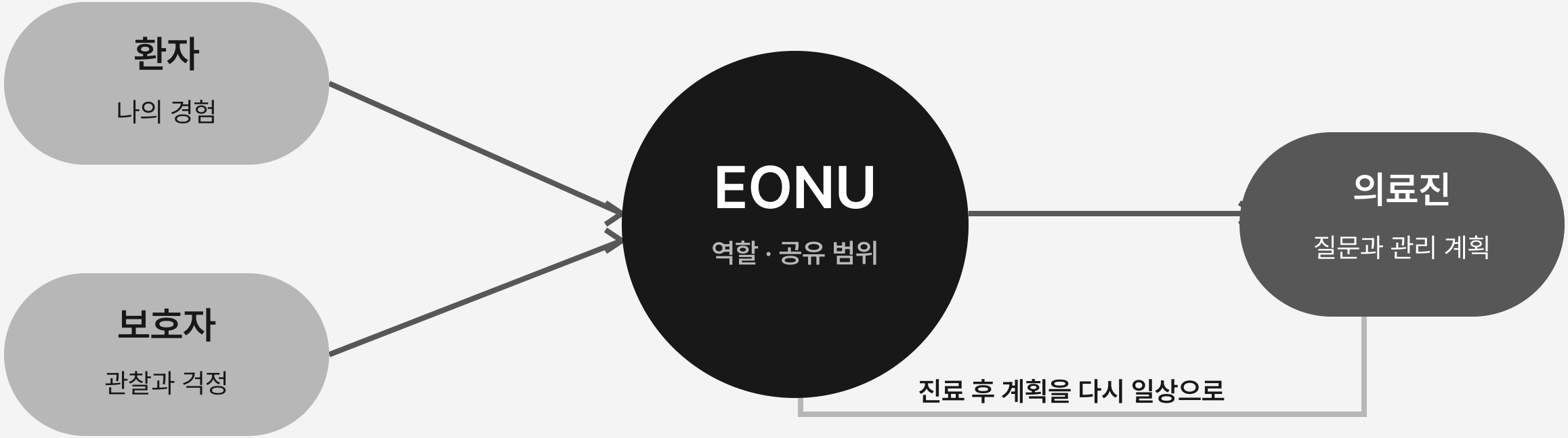
재구성한 설명용 사례

동행의 부재가 만드는 정보 전달의 공백

설명을 위해 재구성한 사례

세 사람의 이야기, 하나의 흐름으로.

환자의 경험 · 보호자의 관찰 · 의료진의 질문과 계획



환자의 걱정이,
병원의 상담 기회로.

의료진이 계속 참여할 세 가지 이유. 먼저 수익 기여 가능성을 검증합니다.

진료 효율

필요한 정보 확인과
전체 업무 부담

임상적 유용성

일상 정보의 의미와
진료 활용 가능성

미해결 걱정 → **병원 정보** → **상담**

정보 제공 → 환자가 자발적으로 요청

먼저 검증할 도입 가치

수익 기여

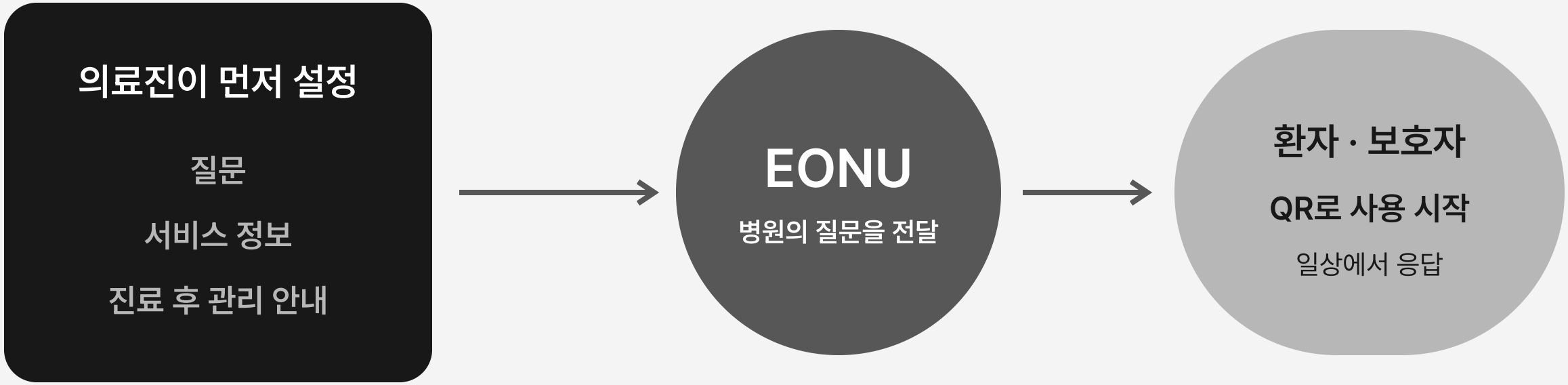
미해결 걱정이
자발적인 상담 요청으로
이어질 수 있을까?

상담 요청 · 지불 의사
업무 부담을 함께 측정

AI가 치료 필요성을
판단하지 않습니다.

병원이 묻고, 일상에서 답합니다.

질문·서비스 정보·관리 안내를 먼저 설정합니다.

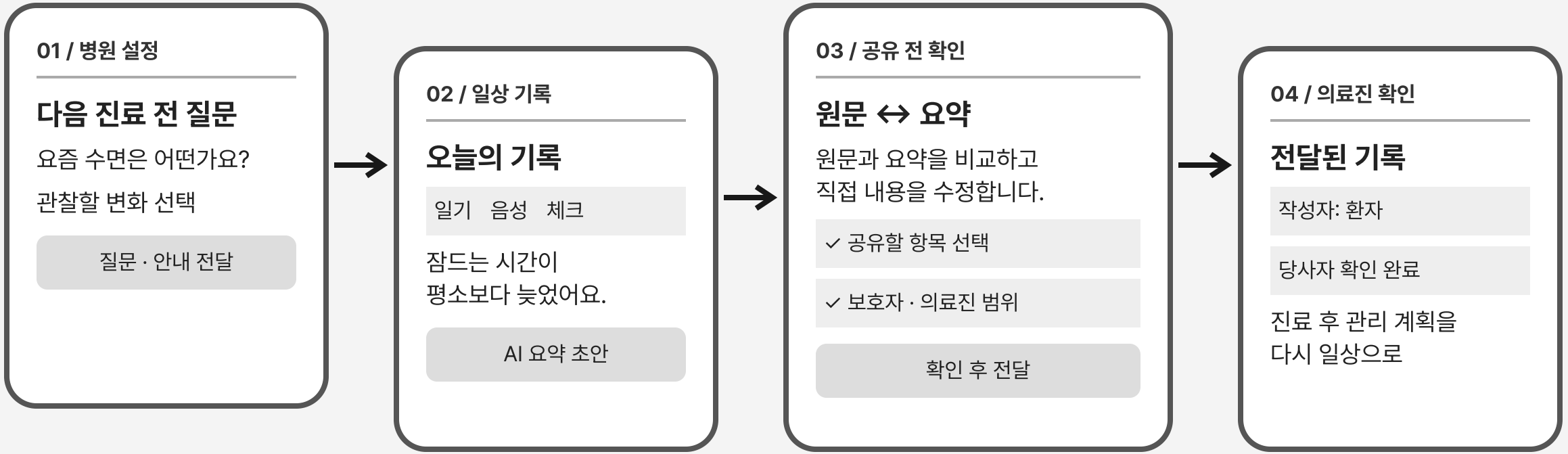


병원 안내 QR은 진입 경로입니다. 실제 접속용 QR은 제공하지 않습니다.

기록은 편하게. 전달은 확인하고.

병원 설정 → 일상 기록 → 공유 전 확인 → 의료진 확인

설명용 UI 도식 · 가상 데이터



첫 매출의 출발점은 병원 라이선스.

일차의료기관에서 유료 도입을 검증하고, 다음 고객으로 넓힙니다.

01 / B2B FIRST

병원 라이선스

일차의료기관의 도입 가치와
지불 의사를 먼저 확인합니다.

첫 병원군 · 가격 · 계약 상태 미확정

→

02 / B2B2C

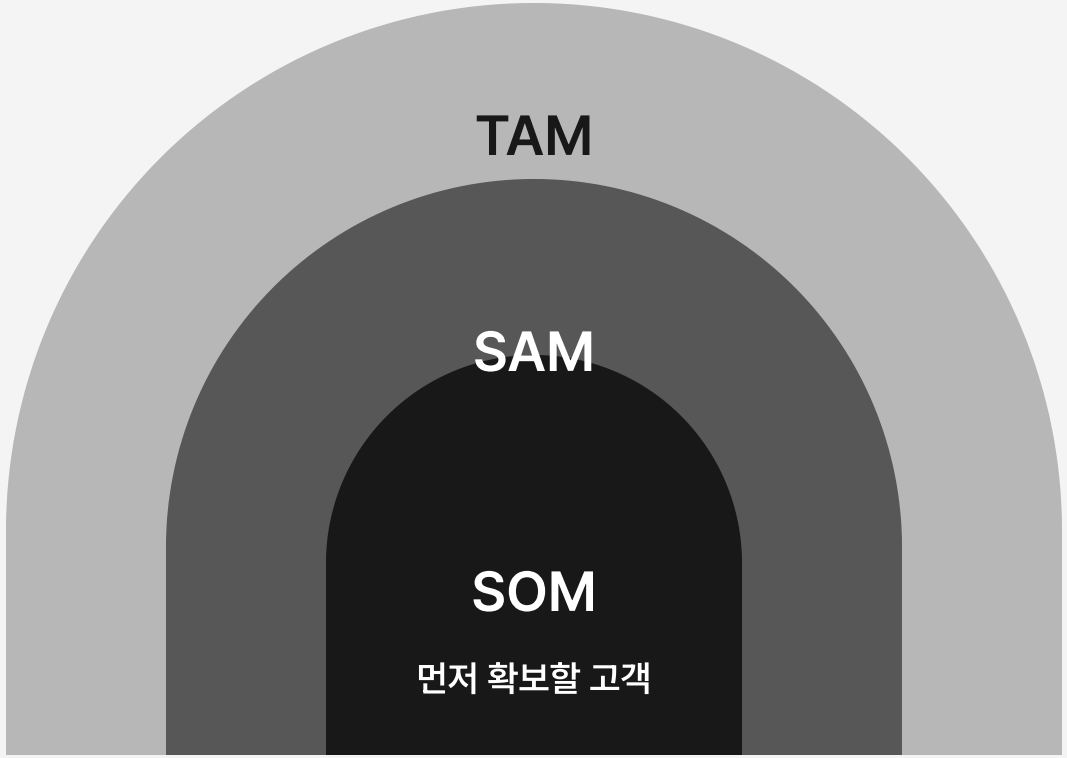
유료 도입 검증 이후
환자·보호자의 추가 가치 탐색

별도 경로 / B2G

실제 구매기관 · 예산 · 공공 계약
연구지원금과 민간 봉사활동은 구분

큰 시장에서, 먼저 살 고객을 좁힙니다.

현재 판매할 소프트웨어를 기준으로 TAM · SAM · SOM을 구분합니다.



구매 단위로 산정합니다.

B2B / 기관 수 × 연간 가격

B2B2C / 사용자 × 전환율 × 연간 지출

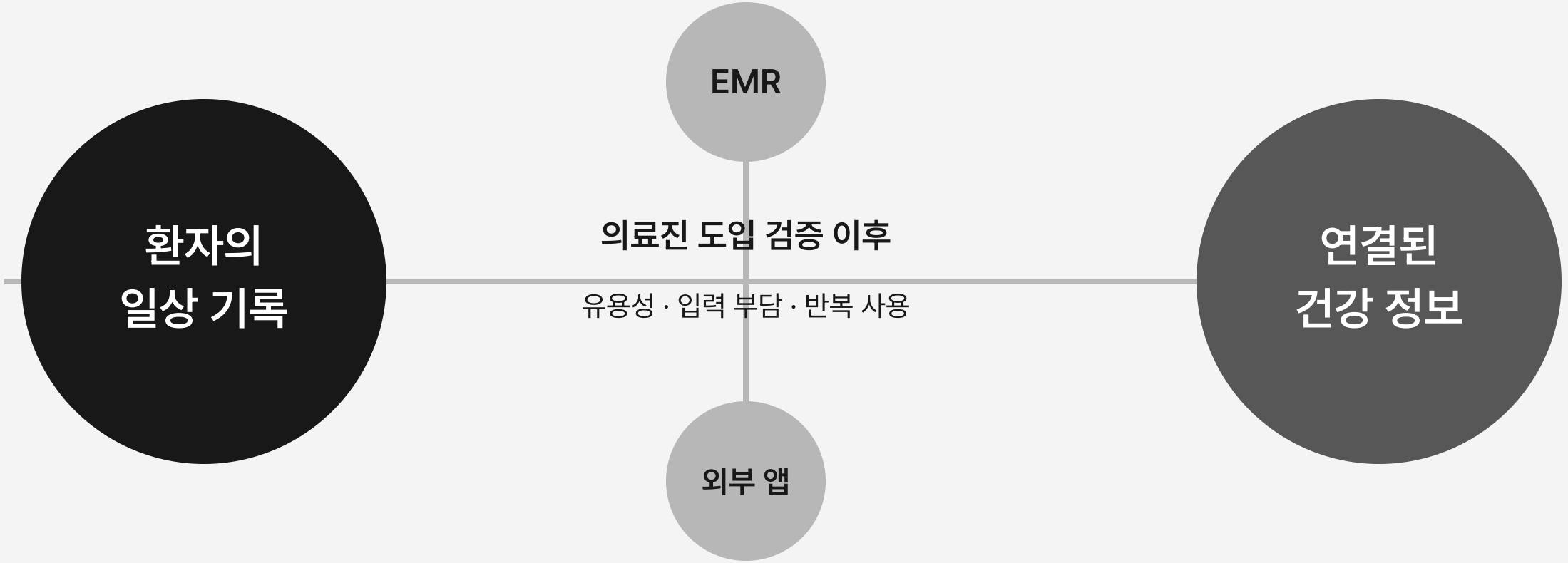
B2G / 구매 건수 × 계약 금액

입력값·가격은 미확정
하드웨어·연구지원금·중복 계약 제외

범위와 산식 개념도 · 면적은 금액에 비례하지 않으며 시장 수치·가격은 산정 전

일상 기록에서, 연결된 건강 정보로.

병원 도입 검증 이후, 정보의 임상적 유용성과 입력 부담을 확인합니다.



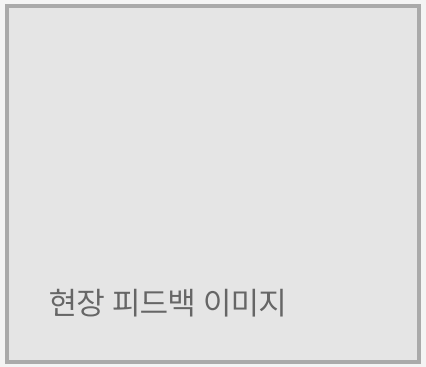
후속 연구: ADHD · 노년층의 기기 연동, 디지털 바이오마커 / 권한·비용·임상적 의미 확인

확장 방향 · EMR·외부 앱·기기 연동 및 바이오마커는 후속 검토·연구

현장 피드백을, 첫 도입으로.

질문과 템플릿, 제품에 반영할 운영 경험을 모으고 있습니다.

MD에 기재된 현재 접점



전문의 피드백

정신건강의학과
전문의의 지속적인 의견

연구기관 접점

기관과의 연락·협의
범위와 증빙 확인

봉사 참여

청년 우울증 관련
프로젝트 운영 경험

다음 검증 → 실제 활용 / 전체 업무 부담 / 반복 사용 / 구매 의사

현재 접점은 공식 제휴·실증·유료 계약 실적으로 합산하지 않습니다.

현재 접점 · 공식 제휴·실증·유료 계약 실적과 구분

1억 원, 첫 유료 모델을 향한 실행 자금.

의료·AI 이해를 바탕으로 직접 기획하고, 개발하고, 수정합니다.



직접 기획 · 개발 · 수정

의료·AI 이해를 바탕으로
제품의 가설을 만들고
현장 피드백을 반영합니다.

필요한 협력
임상 · 개인정보·보안 · 실증

사용계획 총액

1억 원

제품 · 보안 · 실증
고객 확보 · 운영

배분 · 기간 · 기관·고객 목표 [ ]

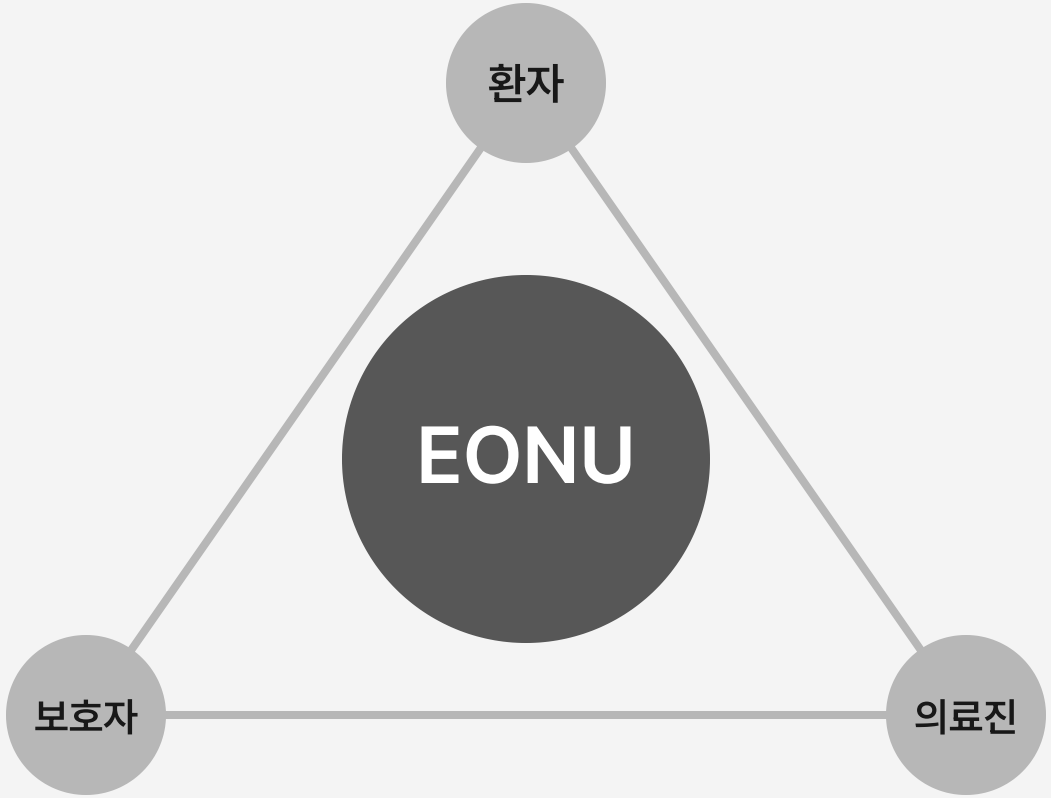
사용계획 총액 · 세부 배분·기간·목표는 확정 전

EONU

환자에게 필요한 연결.
병원도 계속 쓸 이유.

세 사람의 안심을 잇고,
첫 유료 모델의 가치를 검증합니다.

서비스 브랜드 이미지



EONU 이어온유

함께 오지 못해도,
이야기는 함께.

환자와 보호자의 일상을
의료진의 질문에 연결합니다.

AI 소통 솔루션 · IR 2026.10

환자 · 보호자 · 의료진의 일상 장면

환자는 왔지만,
이야기는 오지 못했습니다.

혼자 진료받는 아이와, 곁에 있지 못한 보호자.

한 아이의 진료 장면에서 시작한 질문 · 설명을 위해 재구성한 사례

01

혼자 진료받는 아이

02

곁에 있지 못한 보호자

03

짧은 시간 안에 확인하는 의료진

“언제부터 그랬나요?”

경험은 있지만,
변화를 설명하기 어렵습니다.

“알려드릴 게 있었는데.”

일상의 관찰을 아는 사람은
지금 곁에 없습니다.

“필요한 맥락이 더 있다면.”

이야기가 닿지 못한 자리에
정보의 공백이 남습니다.

세 사람의 이야기,
하나의 흐름으로.

환자의 경험 · 보호자의 관찰 · 의료진의 질문과 계획

PATIENT

환자

내 상황을 이해받고 싶어요.

GUARDIAN

보호자

관찰을 전하고,
진료 후 도울 일을 알고 싶어요.

서로 다른 필요를
하나의 소통 흐름으로

EONU

역할과 공유 범위에 맞게 정리

CLINICIAN

의료진

필요한 정보를 확인하고
질문과 계획을 전달합니다.

진료 후 관리계획 → 다시 일상으로

환자의 걱정이,
병원의 상담 기회로.

의료진이 계속 참여할 세 가지 이유. 먼저 수익 기여 가능성을 검증합니다.

가설 01
진료 효율
전체 확인 업무의 부담까지 함께 측정

가설 02
임상적 유용성
진료에 도움이 되는 맥락과 정보

먼저 검증할 가설
수익 기여 가능성
미해결 걱정이 자발적 상담으로 이어질까?

걱정이 닿는 곳에,
상담의 입구를 만듭니다.

일상에서
미해결 걱정
스스로 느끼는 걱정을
구체적으로 정리

→

병원 정보
관련 정보 탐색
병원이 설정한
서비스 정보 확인

→

당사자 선택
자발적인 상담
상담 요청과 지불 의사,
전체 업무 부담 검증

AI는 개별 치료나 비급여의 필요성을 판단하지 않습니다.

병원이 묻고,
일상에서 답합니다.

질문·서비스 정보·관리 안내를 먼저 설정합니다.

질문과 관리 안내를 설정하는 의료진

병원 설정 · 설명용 UI

다음 진료까지 확인할 것

질문
일상의 변화와 걱정

서비스 정보
병원이 제공하는 안내

관리계획
진료 후 실천할 내용

환자 · 보호자



병원 안내로 시작

해당 병원과 연결된
질문과 안내를 확인합니다.

소통의 출발점은
의료진이 정한 기준입니다.

병원의 질문 → 가족의 관찰 → 다음 진료의 맥락

기록은 편하게.
전달은 확인하고.

병원 설정 → 일상 기록 → 공유 전 확인 → 의료진 확인

설명용 UI 도식 · 가상 데이터 · 실제 서비스 화면 및 EMR 연동 아님



첫 매출의 출발점은 병원 라이선스.

일차의료기관에서 유료 도입을 검증하고, 다음 고객으로 넓힙니다.

먼저 · B2B

병원 라이선스

일차의료기관에서 유료 도입 검증

가상 사례 검토
→ 범위·기간을 정한 제한 실증
→ 유료 제안과 계약

그다음 · B2B2C

추가 유료 가치

병원 도입 검증 이후
환자·보호자가 지불할
추가 가치를 확인합니다.

별도 경로 · B2G

공공 구매 검증

실제 구매기관과 예산이 있는
공공 계약 경로를 확인합니다.

연구지원금·민간 봉사활동과
구분합니다.

첫 병원군과 가격은 선정·검증 중 · 계약 체결을 의미하지 않습니다.

큰 시장에서,
먼저 살 고객을 좁힙니다.

현재 판매할 소프트웨어를 기준으로 TAM · SAM · SOM을 구분합니다.



포함 관계 개념도 · 면적은 금액·비율에 비례하지 않음

B2B

기관 수 × 연간 가격

B2B2C

연결 이용자 × 유료 전환율 × 연간 이용액

B2G

구매사업 수 × 계약 단가

입력값·가격은 산정 전
하드웨어·연구지원금·동일 계약 중복 합산 제외

범위와 산식 개념도 · 면적은 금액에 비례하지 않으며 시장 수치·가격은 산정 전

일상 기록에서,
연결된 건강 정보로.

병원 도입 검증 이후, 정보의 임상적 유용성과 입력 부담을 확인합니다.

병원 도입 검증 이후의 확장 방향 · 연동 및 임상 검증 완료를 뜻하지 않음

환자와 가족의 일상 기록

EONU

임상적 유용성 검토

후속 검토

병원 시스템 · EMR

권한과 연동 비용 확인

후속 검토

외부 건강 앱

환자·가족이 사용하는 정보 연결

추가 연구 과제

기기 · 디지털 바이오마커

ADHD·노년층의 접근성과 임상적 의미 검토

환자의 입력 부담과 반복 사용부터 확인

현장 피드백을,
첫 도입으로.

질문과 템플릿, 제품에 반영할 운영 경험을 모으고 있습니다.

현재 자료에 기재

전문의 피드백

정신과 전문의의 지속적 피드백

자문·협의 범위 확인 필요

현재 접점

연구기관 접점

도헌디지털의료혁신연구소

협의 상태와 범위 확인 필요

참여 확정 기재

청년 우울증 봉사

관련 자선사업 프로젝트 참여

공식 제휴·실증·계약과 구분

다음에는
도입의 증거로.

의료진 실제 활용 | 전체 업무 부담 | 반복 사용 | 구매 의사

질문 · 정보 템플릿 · 운영 경험으로 축적합니다.

1억 원,
첫 유료 모델을 향한 실행 자금.

의료·AI 이해를 바탕으로 직접 기획하고, 개발하고, 수정합니다.

창업자 프로필 사진

의료 · AI 이해를 바탕으로
직접 기획 → 개발 → 수정

1억 원

사용계획 총액

제품을 만들고, 현장에서 유료 가치를 검증합니다.

제품 개발	개인정보·보안	제한 실증	고객 확보	운영

필요한 협력 임상 확인 · 개인정보·보안 · 실증 운영

소개 · 직접 접촉 → 방문 데모 → 파일럿 → 유료 모델 검증

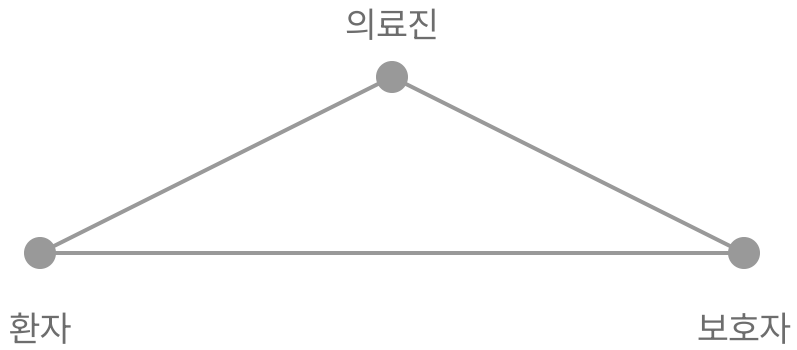
세부 배분·기간·기관 수·유료 고객 목표·CAC는 확정 전

사용계획 총액 · 세부 배분·기간·목표는 확정 전

환자 · 보호자 · 의료진, 이어지는 장면

EONU 이어온유

환자에게 필요한 연결.
병원도 계속 쓸 이유.



첫 병원군과 함께, 실제로 쓰이고 지불할 가치를 검증합니다.

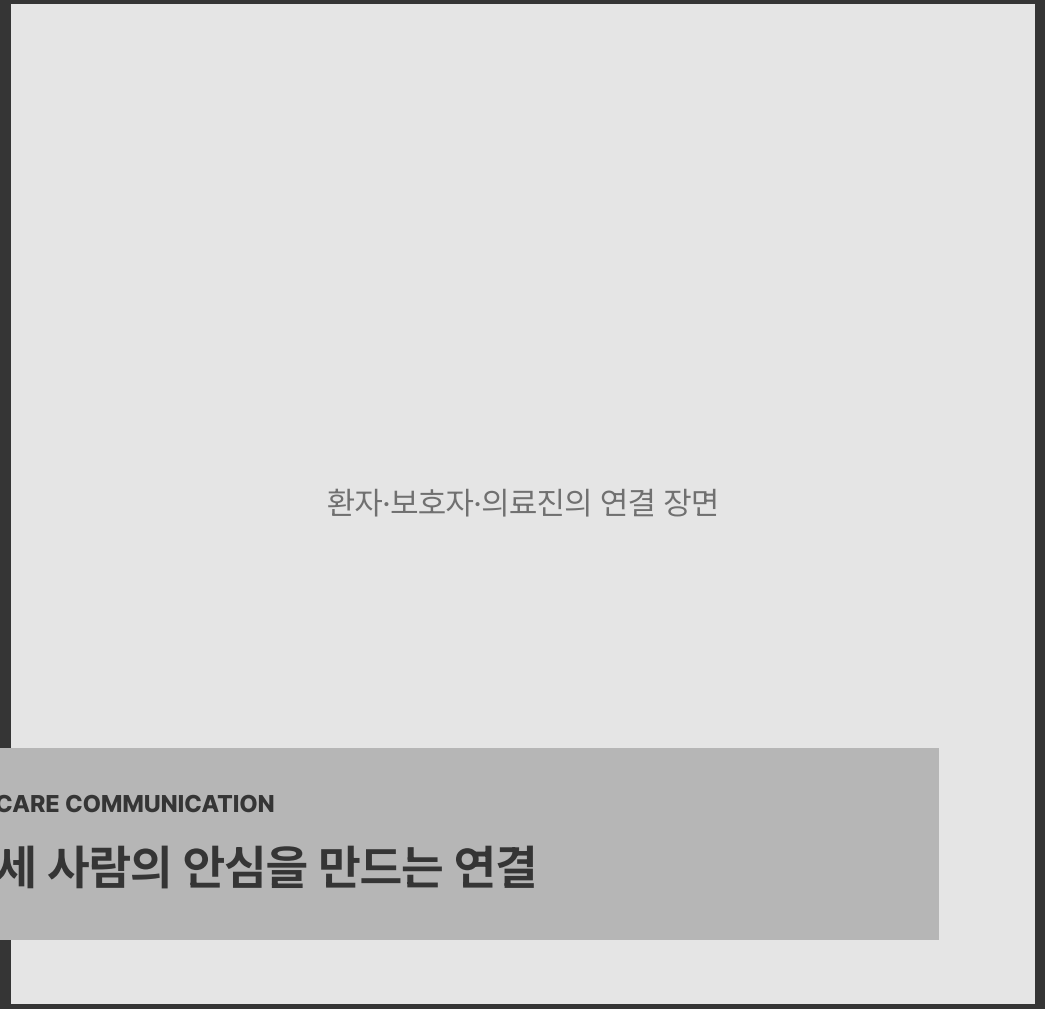
EONU 이어온유

환자 · 보호자 · 의료진 AI 소통

함께 오지 못해도,
이야기는 함께.

일상의 이야기를 진료로,
진료의 계획을 다시 일상으로.

IR PRESENTATION / 2026.10.21



CARE COMMUNICATION

세 사람의 안심을 만드는 연결

환자는 왔지만, 이야기는 오지 못했습니다.

혼자 진료받는 아이와, 곁에 있지 못한 보호자.



진료실 안과 밖

질문은 구체적인데,
관찰은 곁에 없습니다.

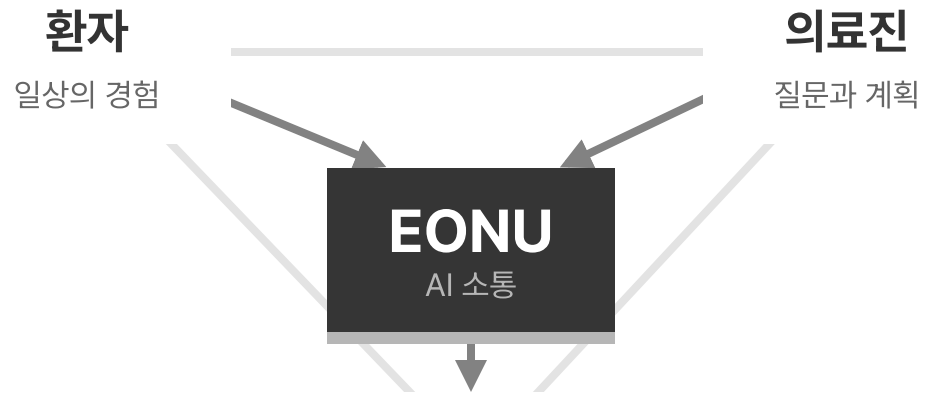
아이	언제부터 달라졌는지 설명하기 어려워요.
보호자	집에서의 변화를 전하고 싶어요.
의료진	필요한 정보를 짧은 시간에 확인해야 합니다.

↗ **동행의 부재가 만드는 정보 전달의 공백**

설명을 위해 재구성한 사례

세 사람의 이야기, 하나의 흐름으로.

환자의 경험 · 보호자의 관찰 · 의료진의 질문과 계획



01 환자
내 상황을 이해받고 싶습니다.

02 보호자
관찰을 전하고, 도울 일을 알고 싶습니다.

03 의료진
필요한 정보를 정리해 확인하고 싶습니다.

↗ **이야기를 정리하고, 역할과 공유 범위에 맞게 전달합니다.**

서비스가 지향하는 연결 구조

환자의 걱정이, 병원의 상담 기회로.

의료진이 계속 참여할 세 가지 이유. 먼저 수익 기여 가능성을 검증합니다.

검증할 도입 가치

진료 효율

전체 업무 부담은 줄어드는가

임상적 유용성

진료에 필요한 정보인가

수익 기여

자발적인 상담으로 이어지는가

먼저 확인할 사업 가설

미해결 걱정을 구체화하면, 상담을 요청할 이유가 생길까요?

미해결 걱정
환자가 느끼는 건강 고민

병원 관련 정보
병원이 설정한 서비스 안내

자발적 상담
환자가 직접 상담 요청

측정할 것 | **상담 요청** | **병원 지불 의사** | **전체 업무 부담**

↗ **AI는 비급여 치료의 필요성을 판단하지 않습니다.**

병원이 묻고, 일상에서 답합니다.

질문·서비스 정보·관리 안내를 먼저 설정합니다.

01 의료진이 먼저 설정
질문 · 서비스 정보 · 관리 안내

→

EONU
병원의 기준을 담는 연결

→

02 환자·보호자 사용 시작
병원 안내 QR 등으로 진입

EONU 의료진 설정 설명용 UI

확인할 질문	**최근 수면과 일상의 변화는 어떤가요?**
안내할 정보	**병원이 제공하는 관련 서비스 정보**
진료 후 안내	**다음 방문 전 확인할 관리 항목**

환자·보호자 연결 화면

↗ **병원의 질문에 맞춰 기록하고, 다음 진료까지 이어갑니다.**

기록은 편하게. 전달은 확인하고.

병원 설정 → 일상 기록 → 공유 전 확인 → 의료진 확인

01 병원 설정 | 02 일상 기록 | 03 공유 전 확인 | 04 의료진 확인

EONU 기록에서 확인까지

가상 데이터 · 설명용 UI

병원 → 일상

이번 주 관리 계획

월	화	수	목	금
✓	✓	오늘	기록	기록

병원 질문

수면 변화 확인하기

진료 후 안내

일상의 변화를 남겨주세요

환자·보호자

편한 방식으로 기록

일기 | 음성 | 체크

보호자 기록 · 가상 예시

어제는 잠들기 어려워했고,
오늘 아침에는 피곤해했어요.

AI가 전달 요약 초안을 정리

공유하기 전

원문과 요약 비교

원문 보기 ↗

최근 수면의 변화가 있습니다.

AI 요약 초안 · 직접 수정 가능

✓ 공유 항목 선택

✓ 공유 대상·범위 조정

확인 후 공유

의료진

출처와 상태 확인

보호자 작성 본인 확인

환자 작성 공유 확인

확인 후

진료에서 필요한 내용 검토

관리 계획을 다시 일상으로 ↩

↗ **기록 → AI 초안 → 당사자 확인 → 의료진 확인 → 일상 관리**

첫 매출의 출발점은 병원 라이선스.

일차의료기관에서 유료 도입을 검증하고, 다음 고객으로 넓힙니다.

INITIAL CUSTOMER

B2B

일차의료기관 라이선스

반복되는 소통 문제 · 도입 가치 · 실증 가능성으로
첫 병원군 선정

→

AFTER PAID VALIDATION

B2B2C

환자·보호자의 추가 유료 가치

병원의 유료 도입 검증 이후 검토

유료 전환까지의 검증 경로

가상 사례 검토
도입 가치 확인

제한 실증
범위·기간·동의 설정

유료 제안·계약
구매 의사 확인

B2G · 별도 경로

실제 공공 구매기관과 예산 확인
공공 구매 계약으로 검증

↗ **가격과 첫 병원군은 검증 중 · 유료 계약 실적을 의미하지 않습니다.**

사업 모델 가설 · 첫 병원군과 가격은 선정·검증 중

큰 시장에서, 먼저 살 고객을 좁힙니다.

현재 판매할 소프트웨어를 기준으로 TAM · SAM · SOM을 구분합니다.



포함 관계 개념도 · 면적은 금액·비율에 비례하지 않음

구매 단위별 산정식

B2B	기관 수 × 연간 가격
B2B2C	연결 이용자 × 유료 전환율 × 연간 이용액
B2G	구매사업 수 × 계약 단가

입력값·시장 수치·가격은 산정 전

동일 계약 중복 합산 제외
미래 하드웨어 매출·연구지원금 제외

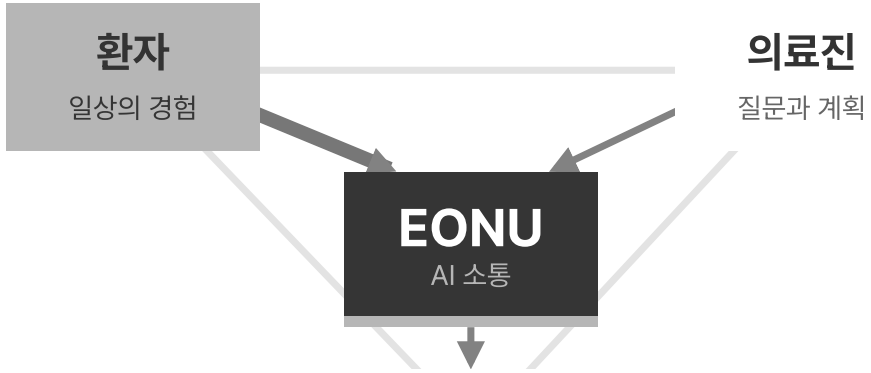
↗ **매출 상한과 실제 확보 목표를 나눠, 먼저 살 고객부터 좁힙니다.**

범위와 산식 개념도 · 면적은 금액에 비례하지 않으며 시장 수치·가격은 산정 전

일상 기록에서, 연결된 건강 정보로.

병원 도입 검증 이후, 정보의 임상적 유용성과 입력 부담을 확인합니다.

출발점은 환자의 일상 정보



먼저 검증

임상적 유용성 · 입력 부담 · 반복 사용

도입 검증 이후의 확장 방향

01 병원 시스템

EMR 연결

권한 · 연동 비용 검토

02 환자·가족의 건강 정보

외부 건강 앱 연결

정보의 활용 가치와 입력 부담 확인

03 ADHD · 노년층 등

기기 연동 · 디지털 바이오마커

접근성과 임상적 의미를 추가 연구

↗ **연동·바이오마커는 후속 검토와 연구 과제입니다.**

현장 피드백을, 첫 도입으로.

질문과 템플릿, 제품에 반영할 운영 경험을 모으고 있습니다.

현재 접점	자료에 기재된 상태
정신건강의학과 전문의	**지속적인 피드백** 자문 범위와 증빙 확인 필요
디지털의료혁신연구소	**기관 접점·협의** 공식 제휴·계약과 구분
청년 우울증 봉사 프로젝트	**참여 확정** 실증·유료 계약과 구분

MVP·협력 범위·법적 검토·실증 상태는 증빙에 맞춰 확정

현장 피드백 · 운영 검토 장면

다음 검증 → 축적할 자산

실제 활용 · 전체 업무 부담
반복 사용 · 구매 의사

질문 / 정보 템플릿 / 운영 경험

↗ **현장 접점을 실제 도입 가치와 구매 의사 검증으로 연결합니다.**

현재 접점 · 공식 제휴·실증·유료 계약 실적과 구분

1억 원, 첫 유료 모델을 향한 실행 자금.

의료·AI 이해를 바탕으로 직접 기획하고, 개발하고, 수정합니다.



직접 기획 · 개발 · 수정

의료·AI에 대한 이해를 바탕으로
제품과 검증을 반복합니다.

필요 협력: 임상 확인 · 개인정보·보안 · 실증 운영

계획 총액

1억 원

첫 유료 모델 검증

제품	개발·개선
보안	개인정보·운영 체계
실증	현장 검증 운영
고객 확보	소개·직접 접촉·방문 데모
운영	서비스 유지·수정

배분 [ ] · 집행 기간 [ ] · 실증 기관 [ ]
유료 고객 목표 [ ] · CAC [ ]

↗ **소개와 직접 접촉, 방문 데모와 파일럿으로 첫 유료 모델을 검증합니다.**

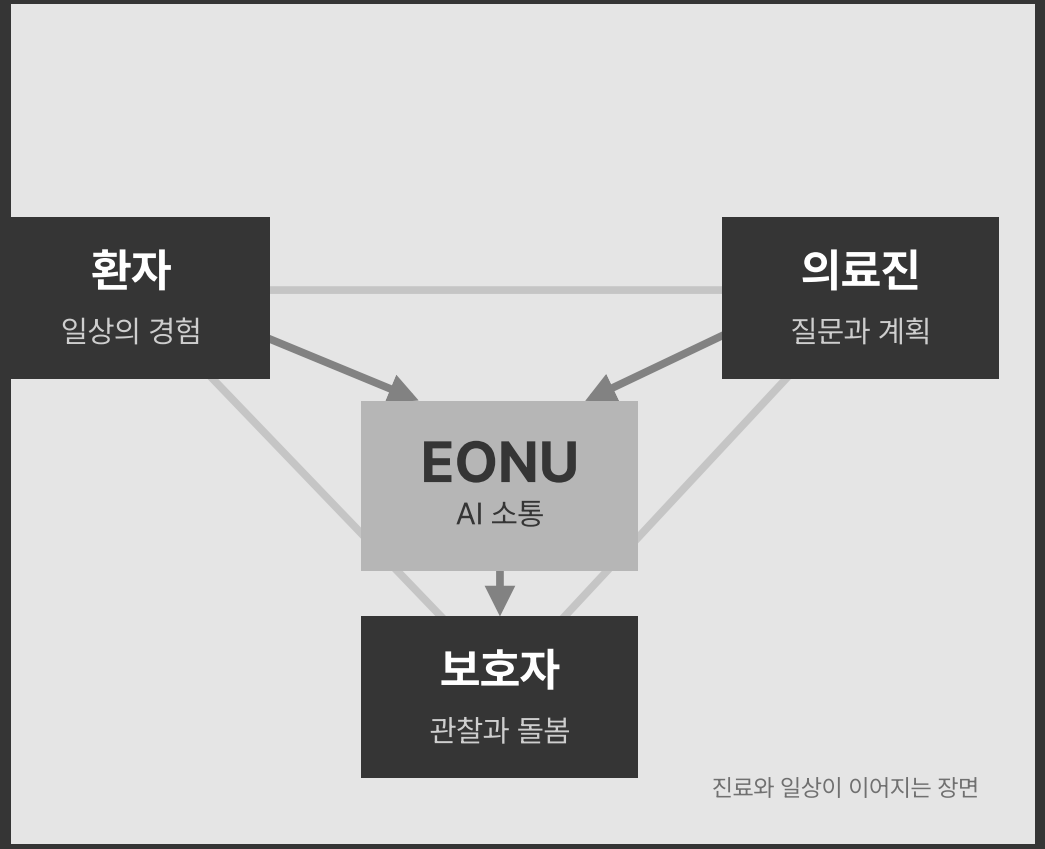
사용계획 총액 · 세부 배분·기간·목표는 확정 전

EONU 이어온유

이어지는 진료, 세 사람의 안심

환자에게 필요한 연결.
병원도 계속 쓸 이유.

실제로 쓰이고, 지불할 가치가 있는지
첫 병원군과 함께 검증하겠습니다.



진료와 일상이 이어지는 장면

감사합니다.